

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

杨少鹏 项目号: T201990151 性别: 男
单位: 博世力士乐(常州)有限公司
联系电话: 182****3079 项目简称: 博世力士乐(常州)有限公司
员工号: 85042056 类别: 员工
卡号: 0512000007558213 部门: DC-AT/EAT2-CN

递送地址:

报告递送方式: 统一

体检号: 3520191129036



爱康卓悦常州龙锦路分院

检查日期: 2019. 11. 29

30 / 6227

爱康卓悦
iKang Excel

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一, 每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系, 爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务, 帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难, 为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时, 爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

爱康的体检中心城市(已在官网正式上线展示的城市)包括: 北京, 上海, 广州, 深圳, 南京, 成都, 凯里, 杭州, 苏州, 重庆, 天津, 长春, 沈阳, 绵阳, 烟台, 济南, 潍坊, 威海, 青岛, 常州, 镇江, 江阴, 无锡, 芜湖, 宁波, 福州, 佛山, 长沙, 武汉, 西安, 银川, 贵阳, 毕节。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 杨少鹏 先生: 您好!

爱康卓悦常州龙锦路分院感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2019年11月29日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果,并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果,隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整,可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同,针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性,本次体检未见异常并不代表没有疾病,如您有不适症状,请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

- 【1】 血压增高
- 【2】 体重指数增高、脂肪肝
- 【3】 甘油三酯增高
- 【4】 甲状腺结节: (超声提示)
- 【5】 阑尾手术史
- 【6】 空腹血糖升高6.12
- 【7】 平均红细胞血红蛋白浓度增高

专家建议与指导

【1】 血压增高:

1、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 为血压增高标准。

2、请近期监测血压,若三次以上非同日测得收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$,有高血压病之可能,建议去医院专科就诊,明确有否高血压病。

3、确诊高血压病后应在专科医师指导下进行药物治疗。

4、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式,戒烟限酒,低脂、低盐、合理膳食,坚持有氧运动,控制体重,减轻精神压力、保持心理平衡等。

【2】 体重指数增高、脂肪肝:

正常的体重指数在18.5-23.99之间,您的体重已属超重范围,同时合并脂肪肝。超重和肥胖是高血压、冠心病的危险因素,也是糖尿病、高脂血症和高血液粘稠度等的病因;脂肪肝多由营养过剩、饮酒、药物损伤导致,加重可导致肝纤维化。您需要调整饮食结构,用低脂、低热、少糖膳食,坚持有氧运动,减轻体重,限酒,慎用伤肝药物,定期复查。听取专科医生的意见。

【3】 甘油三酯增高:

1、建议限酒,低脂、低胆固醇饮食,如少吃油腻及煎烤类食物,少吃动物内脏等,多食蔬菜水果。加强运动,促进脂质代谢。

2、每3-6个月复查血脂和肝脏B超一次,复查前请低脂饮食3天。如血脂持续增高,请在医生指导下使用调脂药物。

【4】 甲状腺结节: (超声提示)

是临床常见的病征,成人中约4%可发生甲状腺结节,恶性病变虽不常见,但术前难以鉴别。若甲状腺结节为孤立结节、突然迅速、无痛地增大或有甲状腺肿瘤家族史者,建议您及时去医院专科做进一步检查,以便明确诊断。

【5】阑尾手术史：
若有不适，请到医院专科复查。

【6】空腹血糖升高6.12：
建议近期复查空腹血糖或餐后2小时血糖及糖化血红蛋白。同时控制膳食总热量，用低脂、少甜食、高纤维素膳食，保持生活规律，适当运动，控制，保持心态平衡。如空腹血糖持续增高，建议内分泌专科就诊。

【7】平均红细胞血红蛋白浓度增高：
暂不必干预。

进一步检查项目建议

（基于发现的异常结果，建议您做以下检查，从而进一步排除或确定您的健康隐患）

序号	发现的异常结果	建议进一步检查的项目 （最终以临床医师意见为准）
1	血压增高	必要时，应进行24小时动态血压监测或家庭血压监测。

主要参考：国家卫生和计划生育委员会、中华医学会、美国癌症学会、美国心脏学会、美国妇产科医师学会等学术机构发布的相关标准

异常结果复查建议

序号	发现的异常结果	复查建议 （最终以临床医师意见为准）
1	体重指数增高	3-12个月复查。
2	甘油三酯增高	3-6个月复查。
3	中度脂肪肝	每年复查一次超声、肝功能。

健康体检结果

· 一般项目检查				检查者：袁婷婷
检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	174.0	cm		
体重	74.8	Kg		
体重指数	24.7		↑	18.5 -- 23.99
收缩压	145	mmHg	↑	90 -- 139
舒张压	94	mmHg	↑	60 -- 89
初步意见	体重指数增高 血压增高			

· 内科	检查者：辛春华
------	---------

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率(次/分)	72	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

· 外科

检查者: 张本健

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	阑尾术后	
初步意见	阑尾手术史	

· 眼科

检查者: 方火香/明金星、刘元媛

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.0	
矫正视力(左)	1.0	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

· 耳鼻咽喉科

检查者: 刘元媛

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

· 血常规

操作者: 徐飞翔 审核者: 孙根喜

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	6.7		3 -- 10	$10^9/L$
红细胞计数	RBC	5.40		4.3 -- 5.8	$10^{12}/L$
血红蛋白	Hb	169.0		130 -- 175	g/L
红细胞压积	HCT	0.452		0.4 -- 0.5	
平均红细胞体积	MCV	83.7		82 -- 100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.3		27 -- 34	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	374.0	↑	316 -- 354	g/L
血小板计数	PLT	258.0		125 -- 350	$10^9/L$
平均血小板体积	MPV	9.6		9.4 -- 12.6	fL
血小板分布宽度	PDW	11.0		9.8 -- 16.2	fL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	39.3		20 -- 50	%
中间细胞百分比	MON%	7.6		0 -- 15	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	53.1		40 -- 75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.6		1.1 -- 3.2	$10^9/L$
中间细胞绝对值	MON#	0.5		0.1 -- 1	$10^9/L$
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.6		1.8 -- 6.3	$10^9/L$
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	31.2		30 -- 53.9	fL
血小板压积	PCT	22.900		10.8 -- 60.8	%
小结	平均红细胞血红蛋白浓度增高				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

· 尿常规

操作者: 赵烨 审核者: 徐飞翔

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.025		1.005 -- 1.030	
尿酸碱度	PH	6.5		5.0 -- 8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL
尿镜检红细胞	RBC	无		0 -- 3	/HP
尿镜检白细胞	WBC	无		0 -- 1	/HP
管型	CAST	无			
上皮细胞	EC	无			
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

· 实验室检查

操作者: 徐飞翔 审核者: 孙根喜

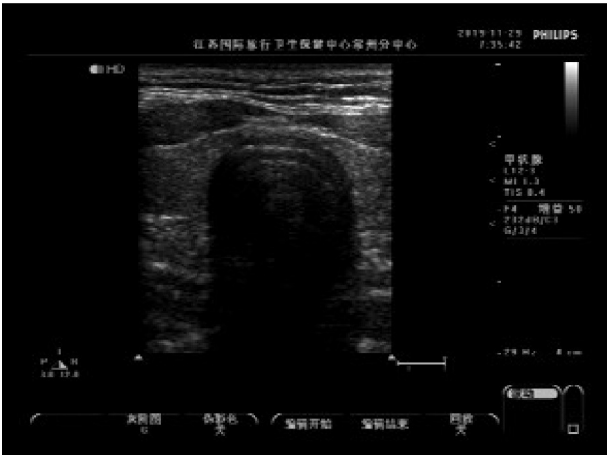
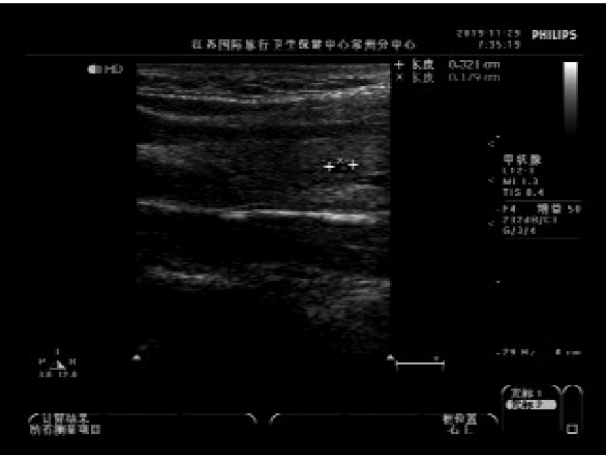
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	46		0.00 -- 50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	16		0 -- 40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	44		0 -- 61	U/L
总蛋白	TP	74.1		60 -- 87	g/L
白蛋白	ALB	50.4		35 -- 55	g/L
球蛋白	GLO	23.70		20 -- 35	g/L
白蛋白/球蛋白比值	A/G	2.1		1.5 -- 2.5	
尿素	UREA	5.0		1.7 -- 8.3	mmol/L
肌酐	Cr	92		44 -- 120	umol/L
尿酸	UA	339		155 -- 428	umol/L
空腹血糖	FBG	6.12	↑	3.89 -- 6.11	mmol/L
总胆固醇	TC	4.59		3.25 -- 6.5	mmol/L

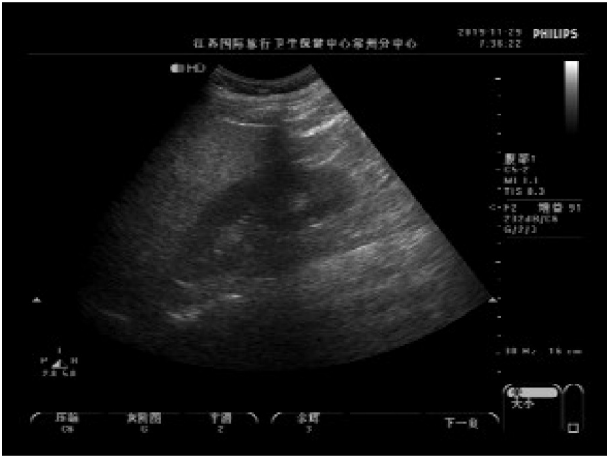
甘油三酯	TG	2.91	↑	0.4 -- 2.3	mmol/L
乳酸脱氢酶	LDH	116		90 -- 250	IU/L
小结	甘油三酯增高 空腹血糖升高				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 心电图室		检查者：吴雪松
检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律，心率在正常范围，P波、P-R间期、QRS波、ST-T未见异常	
初步意见	未见明显异常	

· 超声检查室		检查者：许晴/徐敏
检查项目	检查所见	单位
甲状腺	甲状腺左侧叶见边界尚清晰的单发结节，大小约3.2×1.8mm。CDFI：血流未见明显异常 甲状腺右侧未见明显异常	
肝	肝脏形态饱满，肝内实质回声细腻，略增强，分布不均匀，后方声衰减，肝内血管变细，显示欠清晰，CDFI：血流显示正常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
初步意见	甲状腺结节 中度脂肪肝	





温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

· 放射科		检查者：王小红
检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	
初步意见	未见明显异常	

主检医师：顾和煦

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容, 仅是帮助您解读理解体检报告使用, 所有名词的解释内容, 均出自国家权威性专业典籍, 部分内容略有增减, 仅供您阅读参考。

● 什么是体重指数?

目前常用的体重指数 (body mass index) 简称BMI, 又译为体质指数。在判断肥胖程度时, 使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响, 以便于人群或个体间比较。研究表明, 大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性, 能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性, 如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人, 体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比, 肌肉组织的减少较多, 计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量 (体脂%) 会有助于判断肥胖程度。

● 什么是糖尿病?

糖尿病 (DM) 是一组以高血糖为特征的代谢综合征, 由于体内胰岛素分泌缺陷或其生物学作用障碍而引起的糖、蛋白质、脂肪和水电解质代谢紊乱, 常并发全身微血管、大血管病变, 并可导致心、脑、肾、神经、眼睛及足等器官的慢性功能损害。糖尿病分为1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病, 其中90%以上糖尿病为2型糖尿病。

● 什么是纤维化?

内脏器官等病损后由纤维组织取代或间质纤维组织增生的过程, 叫纤维化。常是变性炎症、缺血、坏死、创伤等引起的后果。如创伤后伤口内产生肉芽组织并逐渐转为纤维化, 最后形成瘢痕。发生在内脏器官 (如心、肺、肝等) 的弥漫性纤维化, 可引起脏器变形、变硬, 故有硬化之称, 如肝硬化。纤维化的后果按其发生部位及范围而异, 如皮肤局限性纤维化的影响较小; 而心瓣膜的纤维化或瘢痕形成, 常引起瓣膜变形, 形成狭窄和闭锁不全, 导致心力衰竭。

● 什么是脂肪肝?

指肝脏内脂肪含量增多, 过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能, 易受亲肝性毒物所损害, 甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性, 在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义, 确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结构。

● 什么是甘油三酯?

常有人将血脂与甘油三酯视为一体, 实际上, 甘油三酯 (TG) 仅是血脂的一种, 血脂还包括其他物质如胆固醇等。当病人的血甘油三酯特别高 (颗粒大、密度低的脂蛋白过多) 时, 血液会呈乳白色, 将这种血静置一段时间后, 血的表面会形成厚厚的一层奶油样物质, 这便是化验单上报告的所谓的“甘油三酯”。甘油三酯的功能与胆固醇截然不同, 甘油三酯是人体主要的能量储存库。尽管甘油三酯有诸多生理功能, 但凡事物极必反, 过多的甘油三酯会导致脂肪细胞功能改变和血液粘稠度增加, 并增加患冠心病的危险性, 而且, 血液中甘油三酯过高还会引起急性胰腺炎。

● 什么是甲状腺结节?

甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块, 其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性, 恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状, 当肿大结节压迫周围组织时, 出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性, 及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者, 下列情况需引起足够的重视: ①颈部放射线检查治疗史; ②有甲状腺癌家族史; ③年龄>70岁; ④结节增长迅速且直径>2cm; ⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难; ⑥结节质地硬、形状不规则、固定; ⑦伴颈部淋巴结肿大。

● 什么是糖化血红蛋白?

血中葡萄糖与红细胞的血红蛋白相结合的产物, 即红细胞的血红蛋白中糖基化部分称为糖化血红蛋白。糖化血红蛋白的多少与血中葡萄糖的含量高低成正比关系, 可以间接反映血糖浓度的改变, 同时也反映了机体糖代谢的状态。糖化血红蛋白测试通常可以反映患者近8~12周的血糖控制情况。空腹血糖和餐后血糖是反映某一具体时间的血糖水平, 容易受到进食和糖代谢等相关因素的影响。糖化血红蛋白可以稳定可靠地反映出检测前120天内的平均血糖水平, 且受抽血时间, 是否空腹, 是否使用胰岛素等因素干扰不大。

● 什么是空腹血糖?

空腹血糖是指在隔夜空腹 (至少8~10小时未进任何食物, 饮水除外) 后, 早餐前采血所测定的血糖值, 是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要的指标, 是目前诊断糖尿病的主要依据, 也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。

● 什么是血红蛋白?

血红蛋白是红细胞内负责运载氧的一种蛋白质, 血液呈红色就是因为含有血红蛋白。它从肺携

带氧, 经由动脉血运送给组织, 又能携带组织代谢所产生的二氧化碳, 经静脉血送到肺再排出体外。生理情况下, 红细胞的生成与衰亡保持动态平衡。多种原因可使这种平衡遭到破坏, 导致红细胞和血红蛋白数量减少或增多。

142C7C3BFFC5D06AA0B35D9DCDC7870EF176B7F4E4AC98F19FA2010FD3646A6

142C7C3BFFC5D06AA0B35D9DCDC7870EF176B7F4E4AC98F19FA2010FD3646A6

iKang 爱康

扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告?
想对比您的历史体检报告?

爱康APP, 检前检后全管理!

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+, 有人“管”的体检!